（二）不稳定型心绞痛的分类 发作频率高(1个月来反复发作)

纤维组织不厚-容易破裂 （初心、静心、变心、恶心）

1.**初发**型心绞痛：在首发症状 1-2 个月内，很轻的体力活动可诱发（程度至少达 CCS III级）

不是慢性冠脉综合征

加拿大心血管病学会 CCS 分级： CCS 00 倒过来的2

I	一般体力活动（步行和登楼）不受限
II	一般体力活动轻度受限：步行＞**200m** 或登楼＞**1 层**时诱发 200米一层楼
III	一般体力活动明显受限：步行＜200m 或登楼 1 层时诱发
IV	一般体力活动完全受限：轻微活动或**休息**时也可发作

2.**静息**型心绞痛：休息时发作、持续时间多＞20 分钟（**多不超过 30 分钟**）30分钟以上的心绞痛优先考虑心梗

要诊断恶化型心绞痛必须先诊断劳力性心绞痛

3.**恶化**型心绞痛：**在相对稳定的劳力性心绞痛基础上逐渐加重而来**，体现在疼痛加剧、持续时间变长、不易缓解、发作频率变高、CCS 增加≥I级

4.**变异**型心绞痛（不稳定型心绞痛的特殊类型）

①冠脉自发地**严重痉挛**致冠脉**完全闭塞** VS 其他不稳定型心绞痛①斑块破了后TXA2↑诱导冠脉痉挛②不完全闭塞

②具备静息型心绞痛的特征（因此睡眠中疼痛警惕静息、变异型心绞痛）

③心电图 **ST 段抬高**（心肌全层/透壁缺血损伤）

对比：其它心绞痛心电图 ST 段压低（心内膜下心肌缺血损伤）

④治疗：**首选 CCB 如硝苯地平**（长效的 控释剂）；ttsx **不宜单用 β-R 拮抗剂**（阻断β2-R加重冠脉痉挛）

β-R拮抗剂(会导致平滑肌痉挛):禁用于变异型心绞痛、雷诺病、支气管哮喘

鉴别:
静息型心绞痛:①符合急性冠脉综合征的机制(在冠脉里堵了不稳定的斑块,白天和夜晚都会发作);②冠脉不完全闭塞→心内膜下缺血损伤→ST段压低
变异型心绞痛:①没有堵斑块,主要在夜晚发作(迷走神经张力高→四负效应→腺苷↓→冠脉痉挛);②冠脉完全闭塞→透壁缺血损伤→ST段抬高

（三）不稳定型心绞痛的治疗 与变异型心绞痛无关

类似稳定型心绞痛，但注意：

1.β-R 拮抗剂应尽早使用，少数高危者可静脉使用艾司洛尔（超短效）；ACEI/ARB/ARNI 应尽早使用

VS稳定型心绞痛:先用阿司匹林/吲哚布芬,放支架后再加替格瑞洛/氯吡格雷

2.**COX-1 抑制剂+P_2Y_{12} 受体拮抗剂双联抗血小板＞1 年，PCI 术中追加血小板 GPIIb/IIIa 受体拮抗剂（替罗非班、阿昔单抗）**三心二意聚精无力阿昔替我上班

粘附:胶原纤维(损伤部位)- vWF-血小板GPIb
聚集:血小板GPIIb/IIIa-纤维蛋白原-血小板

斑块破裂后会暴露出胶原激活凝血系统

3.**在抗血小板的基础上、常规抗凝**（抑制纤维蛋白形成）

①**肝素**。高出血风险者首选磺达肝癸钠（选择性 FX间接抑制剂）肝素增强抗凝血酶活性

②PCI 术中追加**比伐卢定**（直接凝血酶(IIa因子)抑制剂）

VS稳定型心绞痛不需要抗凝

4.**LDL-C＜1.4**mmol/L 糖尿病没有合并冠心病,LDL-C<2.6mmol/L 爱点肉
合并稳定型心绞痛,LDL-C<1.8mmol/L

5.尽快进行**危险分层** 只要是急性冠脉综合征,都建议做PCI,做危险分层是来评估紧急程度的

①对于**极高危**者应紧急（**＜2 小时**）进行 **PCI**

②**极高危者具有下列特点之一**：血流动力学不稳定（心源性**休克**）、**急性心衰**、致命性心律失常（**室颤**）、**心搏骤停**、心梗合并机械并发症（**乳头肌断裂或心脏破裂**）、反复间歇性 ST 段**抬高**、药物治疗无效的反复胸痛（休克心衰、室颤心停、乳断心破、ST 抬高）

ST段压低:心内膜缺血损伤
ST段抬高:全层透壁缺血损伤

不稳定型心绞痛和非ST段抬高型心梗临床表现和治疗基本类似,都适用危险分层